

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5067927-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: RAYSSA TAVARES BARCELOS DOS SANTOS

RECORRIDO: RHAVI LUCCA TAVARES SILVA

MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DA "FÓRMULA INFANTIL EXTENSAMENTE HIDROLISADA SEM LACTOSE (PREGOMIN PEPTI OU ALFARÉ), 15 LATAS CONTENDO 400 GRAMAS POR MÊS". IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A TAL RECURSO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.

5067927-83.2024.4.02.5101

510014488885 .V6

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5067927-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: RAYSSA TAVARES BARCELOS DOS SANTOS

RECORRIDO: RHAVI LUCCA TAVARES SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, na qual a União, objetiva atribuir efeito suspensivo a decisão proferida nos autos originários de nº **5062251-57.2024.4.02.5101** (Evento 36) pelo juízo do Juízo Substituto do 28º VF do Rio de Janeiro que determinou a expedição de RPV antes do trânsito em julgado, com vistas ao fornecimento da "*FÓRMULA INFANTIL EXTENSAMENTE HIDROLISADA SEM LACTOSE (PREGOMIN PEPTI OU ALFARÉ), 15 latas contendo 400 gramas por mês*".

A parte autora, representada por sua genitora apresentou contrarrazões (evento 12).

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de recurso interposto pela União em face da decisão, verbis:

*"RHAVI LUCCA TAVARES SILVA, menor impúbere representado nos autos por sua genitora, RAYSSA TAVARES BARCELOS, propõe ação pelo rito dos Juizados Especiais Federais, com pedido de tutela de urgência, em face da **UNIÃO FEDERAL**, do **ESTADO DO RIO DE JANEIRO** e do **MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, objetivando o fornecimento de fórmula infantil extensamente hidrolisada sem lactose (Pregomin Pepti ou Alfaré), ante diagnóstico de alergia a proteína do leite de vaca (APLV).*

Parte autora patrocinada pela DPU.

Petição inicial instruída com documentos (ev. 1, inic1).

Termo de renúncia do montante que exceder 60 salários mínimos (ev. 1, anexo2, fl. 10).

Decisão concedendo a gratuidade de justiça e intimando o NAT para manifestação técnica (ev. 3).

Parecer do NAT (ev. 7).

É o relatório. Decido.

Em relação à tutela provisória de urgência, a questão demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do art. 300 do CPC.

Saliento que, nos termos do art. 196 da CF/88, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Trata-se, em verdade, de direito de natureza fundamental, cabendo aos seus titulares o direito subjetivo de exigir que o Estado - entendido como a integralidade dos Entes federados - proveja todos os meios necessários ao gozo integral de saúde digna, aí compreendendo o fornecimento de medicamentos, próteses, internações ou, ainda, intervenções cirúrgicas.

Embora, de fato, haja controvérsias acerca dos limites do direito à saúde, sobretudo no que tange à possibilidade de fornecimento de tratamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, tratamentos experimentais ou procedimentos a serem realizados no exterior, o fato é que, uma vez incorporado o tratamento/procedimento/medicamento pleiteado na cobertura do SUS, não cabe à Administração Pública furtar-se do seu dever de fornecer o tratamento, sob pena de descumprimento de normas vinculantes editadas pela própria Administração.

Nessa linha, veja-se que a vinculação da Administração Pública ao fornecimento de assistência integral à saúde em relação a procedimentos incorporados ao Sistema Único de Saúde decorre não apenas de interpretação do art. 196 da CF/88, mas, também, da leitura do art. 6º, inciso I, alínea "d", c/c art. 19-M, inciso I, da Lei nº 8.080/90, que estabelecem o seguinte:

"Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

(...)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em:

I- dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado."

Essa questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em emblemático julgamento da STA nº 175/CE, cujo voto vencedor proferido pelo Min. Gilmar Mendes ressalta que "ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário não está criando política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento. Nesses casos, a existência de um direito subjetivo público a determinada política pública de saúde parece ser evidente".

A mesma conclusão pode ser extraída de voto proferido pelo Min. Roberto Barroso no âmbito do RE nº 566.471/RN, submetido a repercussão geral e ainda pendente de julgamento definitivo, ao assentar que "havendo opção estatal pela inclusão de um fármaco nas listas de dispensação do sistema único de saúde, há a obrigação de fornecê-lo a todos aqueles que dele necessitarem, independentemente de seu custo. Com isso, assegura-se a universalidade das prestações e preserva-se a isonomia na prestação de atendimento aos cidadãos. A atuação do Judiciário volta-se apenas a efetivar as políticas públicas de saúde já formuladas pelo SUS, de modo que o controle jurisdicional nessa hipótese faz parte do natural ofício do magistrado de aplicar a lei".

Assim, uma vez adotada determinada política pública, descabe à Administração deixar de cumpri-la.

Por outro lado, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 106), fixou a seguinte tese quanto a medicamentos não incorporados ao SUS:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) *Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*

(ii) *incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*

(iii) *existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".*

O entendimento possui caráter vinculante, na forma do art. 927, inciso III, do CPC, ao prescrever que os juízes e tribunais observarão "os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos", de modo que cabe analisar a presença dos requisitos acima descritos para fins de análise do pleito. Saliente-se, ademais, que a modulação dos efeitos do julgado apenas atinge o caráter vinculante da decisão, sendo certo que constatações deveras semelhantes foram adotadas pelo STF no julgamento da STA 175, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Pois bem.

No caso dos autos, conforme laudo médico emitido em 14/08/2024 pela Dra. Jasmin Amorim Pacheco (CRM 52129111-4), pediatra do Hospital Federal dos Servidores do Estado, o autor possui diagnóstico de **alergia a proteína do leite de vaca (APLV - CID-10: T78.1)**, necessitando de **fórmula infantil de proteína extensamente hidrolisada sem lactose**, das marcas Pregomin Pepti ou Alfaré, por ser a única fonte de alimento indicada no momento (ev. 1, anexo2, fl. 11).

A médica assistente atesta que, caso não se "inicie o tratamento com o CPAP, "há risco de piora das comorbidades pré-existentes e maior risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e morte súbita" (ev. 1, anexo2, fl. 13).

Conforme o NAT (ev. 7), tanto o Pregomin Pepti quanto a fórmula Alfaré são registrados na Anvisa e indicados para o quadro de saúde do autor.

O núcleo técnico também destaca que fórmulas especializadas para o manejo da APLV foram incorporadas, conforme Portaria SCITIE/MS nº 67/2018, porém ainda não são dispensadas no SUS de forma administrativa, salientando, finalmente, a ausência de publicação de PCDT para a referida alergia.

Em que pese a quantidade indicada no laudo médico (ev. 1, anexo2, fl. 11), o parecer do NAT é mais detalhado e melhor fundamentado a esse respeito, razão pela qual deve ser tomado como parâmetro para fins de cumprimento da tutela de urgência (ev. 7, parecer1, fls. 3/4):

6. Cumpre esclarecer que de acordo com a idade atual do autor 4 meses (Evento 1, ANEXO2, Página 1 - certidão de nascimento) segundo a OMS crianças com estado nutricional adequado, os requerimentos energéticos são de são de 608 kcal/dia. Sendo assim para o atendimento da recomendação energética, seriam necessárias para o Autor 118g por dia de Pregomin® Pepti, totalizando mensalmente 9 latas de 400g ou 5 latas de 800g ou 122g Alfaré® totalizando 10 latas de 400g por mês e não as 15 latas/400g ou 7,5 latas de 800g prescritas e pleiteadas (Pregomin® Pepti ou Alfaré®).

7. Elucida-se que em lactentes a partir dos 6 meses de idade é recomendado o início da introdução da alimentação complementar, com a introdução do almoço incluindo 1 alimento de cada grupo (cereais ou raízes e tubérculos, feijões, legumes e verduras, carnes e ovos) e em lactentes não amamentados, é recomendada a oferta de fórmula infantil 4 vezes ao dia (180-200ml, 4 vezes ao dia, totalizando ao máximo 800ml/dia). A partir do 7º mês de idade corrigida, deve ser introduzido o jantar, e o volume de fórmula reduz-se para 3 vezes ao dia (180-200ml, 3 vezes ao dia, totalizando ao máximo 600ml/dia).

8. Sendo assim, diante do exposto para o atendimento da referida recomendação seriam necessárias 9 latas de 400g/mês ou 5 latas de 800g/mês de Pregomin® Pepti ou 9 latas de 400g/mês de Alfaré®, ao completar 7 meses para o atendimento do volume recomendado; serão necessárias 7 latas de 400g/mês ou 4 latas de 800g de Pregomin® Pepti ou 7 latas de 400g de Alfaré ®.

9. Ressalta-se que as fórmulas supracitadas são substitutos industrializados temporários de alimentos alergênicos, até que a criança desenvolva tolerância ao alérgeno, processo fisiológico que ocorre de maneira gradual, na maioria dos casos, nos primeiros três anos de idade, podendo ocorrer ainda no primeiro ano. **Por isso a necessidade de reavaliações periódicas por profissional de saúde especialista, evitando o uso desnecessário de fórmulas alimentares industrializadas.** Sendo assim sugere-se a delimitação do período de uso das fórmulas prescritas.

Também não é possível restringir a medida de urgência ao fornecimento das duas marcas indicadas na inicial, uma vez que os processos licitatórios obedecem à descrição do produto, e não à marca comercial, bem como à opção mais vantajosa para a administração pública, permitindo a ampla concorrência, em conformidade com a Lei 14.133/2021, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.

Por essas razões, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar que a parte ré forneça ao autor fórmula infantil extensamente hidrolisada sem lactose, sem preferência por marca específica, na quantidade indicada no parecer do NATJUS (ev. 7), levando em consideração a idade da criança, conforme estabelecido naquele documento. **Prazo: 15 dias.**

Para fins de manutenção da tutela de urgência a parte autora deverá juntar aos autos, **a cada 60 (sessenta) dias**, relatório médico atualizado indicando a necessidade da continuidade da medida.

A despeito da solidariedade entre os réus, **direciono o cumprimento do julgado, em primeiro lugar, à UNIÃO**, conforme tese fixada pelo STF no RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux (Tema nº 793), haja vista a informação do NAT de que as fórmulas especializadas para o manejo da APLV ainda não são dispensadas no SUS de forma administrativa.

Em relação à União, intime-se, pessoalmente, por meio do Diretor do Departamento de Gestão de Demandas em Judicialização na Saúde do Ministério da Saúde - com os seguintes endereços eletrônicos: atendimento.satjud@saude.gov.br, apoio.se@saude.gov.br e administrativo.gabse@saude.gov.br, e com endereço físico na Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 3º andar, Ministério da Saúde, Brasília/DF, CEP 70058-900, para ciência e cumprimento da decisão.

O Estado e o Município do Rio de Janeiro serão intimados por mandado através do CADJ.

Eventual impossibilidade de proceder ao cumprimento da tutela de urgência no prazo acima descrito deverá ser noticiada nos autos, não isentando o ente público de demonstrar, no mínimo, as providências até então adotadas para a aquisição.

1 - Considerando-se que não há, em princípio, necessidade de designação de audiência, **citem-se os réus** para, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 9º da Lei nº 10.259/01), apresentarem contestação, bem como se manifestarem sobre eventual proposta de acordo.

No mesmo prazo, deverão apresentar toda documentação de que disponham para esclarecimento da causa (art. 11 da Lei nº 10.259/01).

2 - Alegando os réus fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou em caso de juntada de novos documentos, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 5 (cinco) dias.

3 - Sem prejuízo do item anterior, no mesmo prazo, intinem-se as partes para indicarem as provas que pretendem produzir, esclarecendo, desde logo, sua finalidade.

4 - Nada sendo requerido, venham conclusos para sentença."

A União aduziu a carência de requisitos para a tutela de urgência, ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação para o Município. Requereu o efeito suspensivo e o provimento do feito para a cassação da antecipação dos efeitos da tutela. Na eventualidade de manutenção da tutela provisória de urgência, o direcionamento do cumprimento da ordem judicial ao Município.

É o breve relatório.

Pois bem, sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

No caso, entende-se que a parte autora comprovou ambos os requisitos.

A parte autora comprovou por meio de laudo médico (Evento 1, ANEXO2, Página 11) do Hospital dos Servidores do Estado, que possui alergia a proteína do leite de vaca (APLV - CID.10 T78.1).

O NAT juntou parecer no evento 7, DOC1. Afirmou que as fórmulas são substitutos industrializados temporários de alimentos alergênicos, até que a criança desenvolva tolerância ao alérgeno e que estão registradas na ANVISA.

III – CONCLUSÃO

1. Informa-se que a **alergia à proteína do leite de vaca (APLV)** se caracteriza por uma reação imunológica em resposta a exposição à proteína do leite de vaca, que pode se dar por meio da ingestão de fórmula infantil de rotina ou através do próprio leite materno, se a mãe está consumindo leite de vaca em sua dieta. Dessa forma, quando o lactente está em

aleitamento materno, primeiramente, submete-se a mãe à dieta de exclusão de leite e derivados^{1,5}.

2. Ressalta-se que para os **lactentes com APLV que por algum motivo não estejam sendo amamentados ou o leite materno seja insuficiente, está indicado o uso de fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas**^{1,2}. As fórmulas especializadas podem ser utilizadas até os 6 meses de idade como dieta substitutiva, que proporcione todos os nutrientes necessários, **e em conjunto com a alimentação complementar de 6 a 24 meses de idade**².

3. Em **lactentes com APLV de 6 a 24 meses**, é indicado primeiramente o uso de **fórmulas à base de proteína extensamente hidrolisada (FEH), ou de fórmula infantil à base de proteína de soja (FS)** utilizada somente na ausência de sintomas gastrointestinais, e mediante a não remissão ou piora dos sinais e sintomas com as referidas fórmulas, está indicado o uso de **fórmulas à base de aminoácidos livres (FAA)**^{6,1}.

4. Nesse contexto foi informado em laudo médico (Num. 101804252 - Págs. 1 - 3), que o autor apresenta clínica compatível com **alergia a proteína do leite de vaca**. Dessa forma, mediante ao quadro clínico do autor, é viável o uso de FEH (**Pregomin® Pepti** ou **Alfaré®**) por um período delimitado.

5. Quanto ao **estado nutricional do autor**, foi informado seu peso: 5,800kg, que foi aplicado ao gráfico de crescimento e desenvolvimento para meninos entre 0 e 2 anos de idade, da Caderneta de Saúde da Criança – Ministério da Saúde⁷ e verificou-se que o mesmo se encontra com **peso adequado para idade**.

6. Cumpre esclarecer que de acordo com a idade atual do autor 4 meses (Evento 1, ANEXO2, Página 1 – certidão de nascimento) segundo a OMS crianças com estado nutricional adequado, os requerimentos energéticos são de **são de 608 kcal/dia**⁸. Sendo assim para o atendimento da recomendação energética, seriam necessárias para o Autor **118g por dia de Pregomin® Pepti**, totalizando mensalmente **9 latas de 400g ou 5 latas de 800g ou 122g Alfaré®** totalizando **10 latas de 400g por mês** e não as 15 latas/400g ou 7,5 latas de 800g prescritas e pleiteadas (Pregomin® Pepti ou Alfaré®)^{3,4}.

7. Elucida-se que em lactentes a partir dos 6 meses de idade é recomendado o **início da introdução da alimentação complementar**, com a introdução do almoço incluindo 1 alimento de cada grupo (cereais ou raízes e tubérculos, feijões, legumes e verduras, carnes e ovos) e em lactentes não amamentados, é recomendada a oferta de fórmula infantil 4 vezes ao dia (180-200ml, 4 vezes ao dia, totalizando ao máximo **800ml/dia**). A partir do 7º mês de idade corrigida, deve ser introduzido o jantar, e o volume de fórmula reduz-se para 3 vezes ao dia (180-200ml, 3 vezes ao dia, totalizando ao máximo **600ml/dia**)^{9,10}.

8. Sendo assim, diante do exposto para o atendimento da referida recomendação seriam necessárias^{3,4} **9 latas de 400g/mês ou 5 latas de 800g/mês de Pregomin® Pepti ou 9 latas de 400g/mês de Alfaré®**, ao completar 7 meses para o atendimento do volume recomendado⁵; serão necessárias **7 latas de 400g/mês ou 4 latas de 800g de Pregomin® Pepti ou 7 latas de 400g de Alfaré®**.

9. **Ressalta-se que as fórmulas supracitadas são substitutos industrializados temporários** de alimentos alergênicos, até que a criança desenvolva tolerância ao alérgeno, processo fisiológico que ocorre de maneira gradual, na maioria dos casos, nos primeiros três anos de idade, podendo ocorrer ainda no primeiro ano. Por isso a necessidade de reavaliações periódicas por profissional de saúde especialista, evitando o uso desnecessário de fórmulas alimentares industrializadas. Sendo assim sugere-se a delimitação do período de uso das fórmulas prescritas.

10. Cumpre informar que **Pregomin® Pepti e Alfaré®** possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

11. Salienta-se que **Neocate® LCP possui registro** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Considerando que o item pleiteado foi prescrito utilizando marca comercial, assim, salienta-se que os processos licitatórios obedecem à descrição do produto e não à marca comercial bem como à opção mais vantajosa para a administração pública, permitindo a ampla concorrência, em conformidade com a **Lei 14.133/2021**, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.

12. Salienta-se que **Pregomin® Pepti e Alfaré®** possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Considerando que o item pleiteado foi prescrito utilizando marca comercial, assim, salienta-se que os processos licitatórios obedecem à descrição do produto e não à marca comercial bem como à opção mais vantajosa para a administração pública, permitindo a ampla concorrência, em conformidade com a **Lei 14.133/2021**, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.

13. Esclarece-se que as **fórmulas especializadas para o manejo da APLV foram incorporadas**, conforme Portaria SCITIE/MS nº 67, de 23 de novembro de 2018, para crianças de 0 a 24 meses com **alergia à proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS**¹¹. Porém, **ainda não são dispensadas no SUS de forma administrativa**. Ressalta-se que atualmente existe o **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Alergia à Proteína do Leite de Vaca**, elaborado em abril de 2022, atualmente em fase de encaminhamento para publicação^{2,12}.

14. No que tange ao Programa de Assistência à Criança Portadora de Diarreia Persistente (**PRODIAPE**), presente no Hospital Municipal Jesus (HMJ), informa-se que, segunda a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) **este serviço foi descontinuado e não é mais ofertado**.

É o parecer.

Afirmou o parecer que: "atualmente existe o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Alergia à Proteína do Leite de Vaca, elaborado em abril de 2022, atualmente em fase de encaminhamento para publicação. No que tange ao Programa de Assistência à Criança Portadora de Diarreia Persistente (PRODIAPE), presente no Hospital Municipal Jesus (HMJ), informa-se que, segunda a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) este serviço foi descontinuado e não é mais ofertado."

Restou comprovada a inexistência de alternativa terapêutica fornecida pelo SUS.

Não tendo a parte autora condições financeiras de suportar o tratamento recomendado para o seu quadro clínico, cabe ao Estado providenciar o suporte necessário para tanto, atendendo à exigência do art. 196 da CRFB:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Ademais, como estabelecido na Lei nº 8.080/90, configura objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS) "a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas".

Em relação, especificamente, ao aspecto nutricional, inclui-se, no âmbito do SUS, a "vigilância nutricional e a orientação alimentar" (art. 6º, IV da Lei 8.080/90). Ademais, o art. 13, I, da mesma lei estabelece que a alimentação e nutrição deve ser objeto de especial articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais (art. 12).

O mesmo entendimento, quanto ao fornecimento de **suplemento alimentar**, é adotado pela jurisprudência. Observe:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SAÚDE. SUPLEMENTO ALIMENTAR. **FÓRMULA** INFANTIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. Para fazer jus ao recebimento de medicamentos fornecidos por entes políticos, deve a parte autora comprovar a atual necessidade e ser aquele medicamento requerido insubstituível por outro similar/genérico no caso concreto. (TRF4, AG 5010811-52.2018.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 05/07/2018)

Ainda, no que toca à irreversibilidade dos efeitos de uma possível decisão satisfativa tomada neste momento, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

Quanto ao tema, cabe mencionar o enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil, que assim dispôs: "**ENUNCIADO 40** - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível."

Portanto, afigura-se mais adequado para solucionar o conflito entre o direito à saúde e a capacidade orçamentária do Poder Público, que o aparelho seja fornecido à parte autora.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.

Quanto ao direcionamento da obrigação é possível observar que o insumo não é disponibilizado pela rede pública.

Assim, correta a decisão ao determinar o direcionamento do cumprimento do julgado, em primeiro lugar, à UNIÃO, conforme tese fixada pelo STF no RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux (Tema nº 793).

Por essas razões, indefiro o requerimento de natureza cautelar de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se.

Após, à conclusão para voto."

Logo, a decisão concessiva atacada observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais e não há algum *periculum in mora* inverso ou argumento relacionado a questões de ordem pública relevante, que autorize a concessão da pretendida suspensão da decisão.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar.